Клинические рекомендации

# Головная боль напряжения у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **G44** — Другие синдромы головной боли<br>**G44.2** — Головная боль напряженного типа<br>**G44.3** — Хроническая посттравматическая головная боль<br>**G44.8** — Другой уточненный синдром головной боли<br>**G90.8** — Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы |
| Пациенты | дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России" |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/810_1 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

**3. Диагностика** 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Физикальное обследование 5

3.4 Лабораторные исследования 6

3.5 Нейровизуализация 6

3.6 Дневник головной боли 6

3.7 Дифференциальная диагностика 6

**4. Лечение** 7

4.1 Купирование приступа 7

4.2 Профилактическая терапия 8

4.3 Немедикаментозное лечение 8

4.4 Лечение коморбидных нарушений 9

4.5 Оценка эффекта терапии 9

4.6 Медицинская реабилитация 9

**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** 9
5.1 Профилактика 9
5.2 Показания к госпитализации 10
**6. Источник и актуальность** 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

## 1. Основные положения

- Головная боль напряжения — первичная головная боль: двусторонняя, лёгкой или умеренной интенсивности, сжимающая или давящая, длительностью **от 30 минут до нескольких дней, но менее недели**; не усиливается при обычной физической нагрузке и не сопровождается рвотой.
- Диагноз устанавливается клинически по критериям МКГБ-3. Лабораторные и инструментальные исследования для диагностики не рекомендуются; МРТ или КТ головного мозга показаны только при «сигналах опасности».
- Головную боль напряжения дифференцируют с мигренью, реже — с вторичной головной болью, в том числе при хроническом риносинусите. При подозрении на симптоматическую головную боль показаны консультации специалистов, среди которых чаще всего — офтальмолог и оториноларинголог.
- Для купирования приступа применяют парацетамол или ибупрофен, если приступы возникают **не чаще 2 раз в неделю**. Обезболивающие **более 2 (максимум 3) раз в неделю** не рекомендуются из-за риска лекарственного абузуса; при частой эпизодической и хронической форме проводится профилактическая терапия.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Головная боль напряжения (ГБН) — одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли. Проявляется продолжительными приступами двусторонней головной боли лёгкой или умеренной интенсивности, сжимающего, давящего или ноющего характера.

Длительность приступа — **от 30 минут до нескольких дней**, но менее недели. Возможна свето- или звукобоязнь, но не обе сразу; боль не усиливается при повседневной физической активности и не сопровождается рвотой.

### 2.2 Этиология и эпидемиология

В патогенезе задействованы периферические (мышечный спазм) и центральные механизмы боли (центральная сенситизация и дезингибиция); начальные звенья связаны с напряжением перикраниальных мышц в ответ на эмоциональный стресс. У детей незрелость механизмов психологической защиты приводит к проявлению заболевания при незначительных, с точки зрения взрослых, стрессовых факторах.

**Предрасполагающие факторы**

1. высокий уровень тревожности;
2. значимая психотравмирующая ситуация, трудности адаптации к новой обстановке;
3. неспособность к психологическому и мышечному расслаблению;
4. расстройства сна;
5. психическое переутомление, зрительные нагрузки, в том числе за компьютером;
6. статическое (познотоническое) напряжение — длительное вынужденное положение головы и шеи.

ГБН — наиболее распространённая форма первичной головной боли; средний возраст начала — 7 лет. Ею страдают 5–20,5% детей и подростков, у взрослых распространённость достигает 30–80%.

### 2.3 Классификация

**Варианты по частоте приступов (МКГБ-3)**

1. **нечастая эпизодическая** — **не более 1 раза в месяц (не более 12 дней в году)** при не менее чем 10 перенесённых эпизодах
2. **частая эпизодическая** — **от 1 до 15 раз в месяц** в среднем более 3 месяцев (12–180 дней в году)
3. **хроническая** — **15 дней и более в месяц** в среднем более 3 месяцев (более 180 дней в году)

Каждый вариант может наблюдаться без напряжения и с напряжением перикраниальных мышц.

### 2.4 Клиническая картина

Боль постоянная, давящая.

**Локализация**

1. в большинстве случаев — лоб и виски с иррадиацией в затылочную область и заднюю поверхность шеи;
2. затем боль становится диффузной: ощущение сжатия головы обручем, симптом «шлема» или «каски»;
3. наибольшая интенсивность в течение дня может перемещаться с одной половины головы на другую; стойкая односторонняя боль, как правило, связана с повышенной чувствительностью перикраниальных мышц.

Как правило, боль появляется днём (после 2–3-го урока) или во второй половине дня и продолжается до вечера; повседневная нагрузка её не усиливает. Транзиторные неврологические симптомы не характерны.

Течение может быть длительным, многолетним, возможна хронизация. При своевременной диагностике и адекватной терапии у многих детей достигается клиническая ремиссия.

---

## 3. Диагностика

### 3.1 Критерии диагноза

Диагноз ГБН основывается на клинических проявлениях в соответствии с критериями МКГБ-3 (2018).

**Диагностические критерии нечастой эпизодической ГБН**

1. A. Не менее 10 эпизодов с частотой **не более 1 дня в месяц** (не более 12 дней в году), отвечающих пунктам B–D.
2. B. Длительность **от 30 минут до 7 суток** (у детей может быть до 30 минут).
3. C. Не менее 2 характеристик: двусторонняя локализация; стягивающий, давящий, не пульсирующий характер; лёгкая или умеренная интенсивность; боль не усиливается при обычной физической нагрузке.
4. D. Оба признака: отсутствие тошноты или рвоты (возможно снижение аппетита); только фотофобия или только фонофобия.
5. E. Боль не соответствует в большей степени другому диагнозу МКГБ-3.

При повышенной болезненности перикраниальных мышц при пальпации устанавливается диагноз ГБН, сочетающейся с напряжением перикраниальных мышц.

Частая эпизодическая ГБН: не менее 10 эпизодов **от 1 до 14 дней в месяц** (более 12 дней в среднем более 3 месяцев и менее 180 дней в году); критерии B–E те же.

Хроническая ГБН: головная боль **15 и более дней в месяц** в среднем более 3 месяцев (более 180 дней в году); критерии B–E те же.

### 3.2 Жалобы и анамнез

**При сборе анамнеза уточняют**

1. время дебюта, частоту, провоцирующие факторы;
2. длительность и локализацию боли;
3. характер боли;
4. сопровождающие симптомы.

**Характерные признаки ГБН**

1. повторяющиеся эпизоды двусторонней диффузной сжимающей или давящей, не пульсирующей боли по типу «каски» или «обруча»;
2. локализация в лобной, височной, теменной, возможно затылочной области или во всей голове;
3. слабая или умеренная интенсивность — 4–7 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ);
4. прогулка на свежем воздухе может облегчить боль;
5. возможны лёгкая тошнота и снижение аппетита; фото- и фонофобия редки и не развиваются одновременно.

Интенсивность боли в приступе оценивают по ВАШ — у детей совместно с родителями.

### 3.3 Физикальное обследование

Детям с головной болью проводится тщательный общеклинический и неврологический осмотр для исключения симптоматического характера боли. При ГБН общемозговые и очаговые симптомы не выявляются, но при пальпации может определяться повышенная болезненность перикраниальных мышц.

**Пальпация для выявления напряжения мышц и «триггерных» точек**

1. височная, лобная, затылочная области;
2. мышцы задней поверхности шеи;
3. трапециевидные и грудино-ключично-сосцевидные мышцы.

При подозрении на симптоматическую природу головной боли показаны консультации специалистов.

**Чаще всего**

1. офтальмолог;
2. оториноларинголог;
3. травматолог-ортопед;
4. эндокринолог;
5. нейрохирург.

При выраженных эмоционально-личностных, соматоформных и сенесто-ипохондрических расстройствах показана консультация психиатра: они учащают головную боль и снижают качество жизни.

**Типичные коморбидные нарушения у детей с ГБН**

1. тревожные и/или депрессивные расстройства;
2. нарушения поведения;
3. синдром дефицита внимания и гиперактивности;
4. астенический синдром;
5. нарушения сна;
6. другие болевые синдромы.

### 3.4 Лабораторные исследования

Лабораторные исследования для диагностики ГБН не рекомендуются: специфических изменений они не выявляют.

**Показания к дополнительным исследованиям**

1. сомнения в диагнозе первичной головной боли: нетипичные жалобы или течение, невыполнение более одного критерия;
2. выполнение критериев вторичной головной боли;
3. один или более «сигналов опасности»;
4. требование пациента или его родственников.

В этих случаях выполняются общий (клинический) анализ крови, исследования общевоспалительных реакций, коагулограмма, динамическое измерение артериального давления вне приступа и во время приступа.

### 3.5 Нейровизуализация

Инструментальные исследования для диагностики ГБН не рекомендуются; нейровизуализация при повторяющейся головной боли без изменений неврологического статуса и ЭЭГ нецелесообразны.

**«Сигналы опасности» — показания к МРТ или КТ головного мозга**

1. внезапная впервые возникшая интенсивная головная боль;
2. прогрессивно нарастающая интенсивность без ремиссий;
3. изменение характера хронической головной боли;
4. сочетание с очаговой симптоматикой, продолжающейся **более 1 часа**;
5. сочетание с нарушением сознания и расстройством поведения;
6. строго односторонняя боль, признаки внутричерепной гипертензии и системного заболевания.

Детям с головной болью показано исследование глазного дна для исключения отёка зрительного нерва и повышения внутричерепного давления; офтальмологическое обследование может включать остроту и поля зрения, выявление спазма аккомодации.

### 3.6 Дневник головной боли

Ведение дневника головной боли **в течение 1–3 месяцев** позволяет установить число дней с болью и с приёмом обезболивающих в месяц, отличить приступ мигрени от эпизода ГБН. При обращении в специализированные центры головной боли дневник обязателен.

### 3.7 Дифференциальная диагностика

ГБН дифференцируют с мигренью, реже — с вторичной головной болью: при изменении ликворного давления, цервикогенной, при хронических риносинуситах, при других неврологических заболеваниях.

**Идиопатическая внутричерепная гипертензия**

1. повышение внутричерепного давления при нормальных данных КТ или МРТ;
2. боль диффузная, с максимумом в лобной области, усиливается при кашле, чихании, наклоне головы вниз;
3. двоение и боль в глазах, шум в ушах;
4. отёк диска зрительного нерва и паралич VI черепного нерва.

Головная боль при хронических риносинуситах продолжительная и периодическая: максимум приходится на середину дня.

При фронтите боль постоянная и, как правило, интенсивная, особенно при затруднении оттока отделяемого. Она локализуется в лобной области с максимумом в области переносицы.

**Боль усиливается**

1. при давлении или постукивании по передней стенке лобной пазухи;
2. при физическом напряжении, кашле, чихании;
3. при поворотах головы, в положении лёжа на животе.

Дети часто жалуются на светобоязнь, слезотечение и обильные выделения из соответствующей половины носа, особенно утром при переходе в вертикальное положение. Диагноз подтверждается риноскопией и рентгенографией лобных пазух.

При подозрении на цервикогенную головную боль показаны рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, снимок атлантоокципитального сочленения или МРТ шеи. После травмы шейного отдела боль возникает после нагрузки на шею, локализуется в шее, затылочной области и области сосцевидных отростков, усиливается при движениях головой и пальпации; характерны вынужденное положение и ограничение подвижности головы.

**Симптомы, требующие исключения неврологических заболеваний и соматической патологии**

1. изменения уровня сознания: оглушённость, спутанность;
2. диффузная боль, прогрессивно нарастающая с каждым днём;
3. постоянная многомесячная боль, не поддающаяся терапии;
4. утренняя боль с многократной рвотой без тошноты;
5. зависимость интенсивности от положения головы и тела;
6. внезапная новая, необычная для пациента тяжёлая боль;
7. очаговые неврологические симптомы;
8. нарастание боли параллельно с повышением температуры, симптомы системного заболевания: лихорадка, артралгии, миалгии.

Исключают внутричерепные объёмные процессы (опухоль, абсцесс) и нейроинфекции (менингит, энцефалит).

---

## 4. Лечение

Лечение включает фармакотерапию и немедикаментозные методы; стратегия зависит от частоты приступов и коморбидных нарушений.

При эпизодической ГБН с частотой **более 2 приступов в неделю** предпочтительнее профилактическое лечение, чем купирование приступов.

При хронической ГБН обезболивающие сомнительно эффективны и повышают риск лекарственно индуцированной головной боли, поэтому основное значение имеет профилактическая терапия.

### 4.1 Купирование приступа

При нечастой и частой эпизодической ГБН с приступами **не чаще 2 раз в неделю** применяется парацетамол в самом начале приступа.

1. дети: 10–15 мг/кг на приём
2. повторно: **через 6–8 часов**

При приступах умеренной и высокой интенсивности **не чаще 2 раз в неделю** применяется ибупрофен в начале приступа; по обезболивающему эффекту и действию на ЖКТ и почки он сопоставим с парацетамолом, но не оказывает токсического действия на печень.

1. дети: 7,5 мг/кг на приём

Для купирования приступов умеренной и высокой интенсивности применяется кетопрофен (лизиновая соль, гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь).

1. дети **старше 6 лет**: 40 мг на приём, до 3 раз в сутки

При частых приступах не рекомендуется применять обезболивающие **более 2 (максимум 3) раз в неделю** из-за высокого риска лекарственного абузуса.

**Для купирования ГБН у детей не рекомендуются**

1. **метамизол натрия** — высокий риск агранулоцитоза
2. **салициловая кислота и её производные** — риск синдрома Рейе
3. **комбинированные анальгетики с кофеином, фенобарбиталом, эрготамином или кодеином** — высокий риск лекарственно индуцированной головной боли

### 4.2 Профилактическая терапия

Детям с частой эпизодической и хронической ГБН проводится профилактическая терапия для уменьшения числа дней с головной болью в месяц.

При выраженном отрицательном влиянии боли на повседневную активность применяется #амитриптилин внутрь. Перед назначением регистрируется ЭКГ; дневная сонливость часто возникает при дозе выше 30–40 мг в сутки, другие побочные эффекты — ортостатическая гипотензия и антихолинергические.

1. начальная доза: 5–10 мг (или 0,25 мг/кг) перед сном
2. повышение: на 0,25 мг/кг **каждые 2–3 недели** до 1 мг/кг/сут
3. длительность: **от 2 месяцев** при частой эпизодической, **4–6 месяцев** при хронической ГБН

При неэффективности #амитриптилина **в течение 2–3 месяцев** назначается фиксированная комбинация #магния и пиридоксина или #вальпроевая кислота. У девочек в пре- и пубертатном периоде учитывают возможные нежелательные эффекты вальпроевой кислоты со стороны эндокринной системы.

1. магний + пиридоксин: из расчёта магния пидолата 200–300 мг в сутки в 2 приёма внутрь (раствор)
2. вальпроевая кислота: внутрь с постепенным повышением дозы до 10–20 мг/кг/сут

### 4.3 Немедикаментозное лечение

**При слабой интенсивности боли**

1. прогулки на свежем воздухе;
2. физические упражнения умеренной интенсивности;
3. массаж волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны;
4. тёплый душ;
5. сон.

**Для повышения адаптационных возможностей ЦНС и уменьшения мышечно-тонического синдрома**

1. когнитивно-поведенческая терапия;
2. постизометрическая мышечная релаксация;
3. дыхательный релаксационный тренинг;
4. биологическая обратная связь;
5. аутогенная тренировка.

Показаны занятия с психологом, психотерапевтом для выработки стратегии поведения в стрессовой ситуации и уменьшения тревожности.

Детям школьного возраста и подросткам проводится когнитивно-поведенческая терапия: её основа — выявление и устранение ситуации хронического стресса и разъяснение природы ГБН, в том числе роли эмоциональных факторов и перенапряжения перикраниальных мышц.

**Необходимые компоненты**

1. исключение провокаторов головной боли;
2. режим питания и гигиена сна;
3. рациональное распределение физических, умственных и психоэмоциональных нагрузок;
4. регулярные оздоровительные спортивные занятия;
5. обучение психологической и мышечной релаксации.

При напряжении перикраниальных мышц проводится курс биологической обратной связи по электромиографическому сигналу.

### 4.4 Лечение коморбидных нарушений

1. **тревожные расстройства и эмоциональные нарушения** — анксиолитики и антипсихотические средства
2. **тревожные и депрессивные расстройства** — антидепрессанты, разрешённые у детей и подростков: амитриптилин, сертралин внутрь 12,5–25 мг 1 раз в сутки, через неделю 50 мг/сут, курс 6–8 недель
3. **астенические нарушения** — #левокарнитин и #деанола ацеглумат
4. **неэффективность немедикаментозных методов и невозможность лечения амитриптилином** — ноотропные препараты с седативным действием — #гопантеновая кислота и #аминофенилмасляная кислота 15–20 мг/кг в день внутрь в 2–3 приёма при частой эпизодической и хронической ГБН

### 4.5 Оценка эффекта терапии

Эффективность профилактического лечения оценивают по уменьшению среднего числа приступов в месяц **на 50% и более**; исходную частоту определяют за **2 месяца** до начала лечения.

**Дополнительные критерии**

1. снижение интенсивности боли по 10-балльной ВАШ;
2. снижение влияния боли на повседневную активность по HIT-6;
3. уменьшение приёма обезболивающих;
4. уменьшение коморбидных нарушений: улучшение настроения, снижение тревоги, нормализация сна.

### 4.6 Медицинская реабилитация

Реабилитационные мероприятия у детей с ГБН не разработаны.

---

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Профилактика

Детям и подросткам разъясняют роль провоцирующих факторов и необходимость их избегать: познотонического мышечного и избыточного эмоционального напряжения, стресса, нарушений сна.

### 5.2 Показания к госпитализации

**Плановая госпитализация**

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. подозрение на симптоматическую природу боли при «сигналах опасности».

**Экстренная госпитализация**

1. головная боль с изменением сознания;
2. головная боль с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. нарастающая очаговая неврологическая симптоматика;
4. нарастающая общемозговая симптоматика;
5. боль крайне высокой интенсивности — **10 баллов по ВАШ**.

**Критерии выписки**

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**;
3. выяснение причины вторичной головной боли и выбор лечебного подхода.

---

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Головная боль напряжения» |
| Версия | 1-я, опубликована в рубрикаторе 15.11.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года |
| Код в рубрикаторе | 810_1 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Всероссийское общество неврологов; Союз реабилитологов России |
| Пациенты | Дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Граница частой эпизодической и хронической формы: в классификации (1.5) частая эпизодическая ГБН — «от 1 до 15 раз в месяц», а хроническая — «15 дней и более»; в диагностических критериях (раздел 2) частая эпизодическая — «от 1 до 14 дней в месяц». От формы зависит длительность профилактического курса амитриптилина (от 2 месяцев или 4–6 месяцев).